EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 71558
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-09-29 11:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CECILIA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ			RUN	: 11.073.633-9
F.Nac	: 25-09-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-09-26	Fecha Egreso	: 2023-09-29 11:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico putaminal y corona radiada izquierdos, etiología obs lacunar

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Diestra mRS 0 Previamente asintomática, suspendió tratamiento crónico al menos hace 4 días. Consultó el 25/09/23 por debilidad se hemicuerpo derecho y disartria de inicio brusco a las 15 horas. Al ingreso de SU de HSC con FC 88 lpm, PA 190/100 mmHg, sat 99%, T° 36.1°C y HGT 322 mg/dL. Al examen de ingreso se describe con hemiparesia FBC derecha M3, se activa evaluación por teleneurología y se realizó estudio complementario con laboratorio en que destaca hiperglicemia, sin otras alteraciones. En angioTC de cerebro y cuello, no se hacen evidentes lesiones agudas en parénquima, microangiopatía. En fase angiográfica sin estenosis significativas intra ni extracraneanas. Se desestima trombolisis farmacológica por tiempo, y sin indicación de trombectomía mecánica. Durante estadía en servicio de urgencias con necesidad de múltiples rescates de antihipertensivos labetalol 20 mg en 4 ocasiones, y urapidil 25 mg en 2. Se hospitaliza para estudio y tratamiento. Durante la noche se mantiene con sensación nauseosa que se controla con ondansetrón, hipertensión arterial permisiva, sin cefalea, sin otras molestias. Monitorización cardiológica sin arritmias.

Evolución
Paciente BEG, HDN con HTA moderada, RS al monitor, afebril, eupneica, hiperglicemia moderada con requerimientos de IC, tolera bien alimentación VO, tranquila y cooperadora, no refiere molestias.
TC cerebro s/c muestra infarto consolidado putaminal y corona radiada izquierdos, y otros secuelares yuxtacortical fronto-mesial derecho y adyacente a asta anterior de VL izquierdo (presente en TC previos), asociados a extensa leucoaraiosis Fazekas tipo 2.
Diuresis(+) dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días
-EDA
-LM desde el 25/9/23 por 60 días
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Omeprazol 20 mg/día
3. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
4. -Losartan 50 mg c/12h
5. -Amlodipino 10 mg/d
6. -Metformina 850 mg c/12h
7. -Insulina NPH 10U AM

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no plapo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N
-PC: CV N por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria(-), nistagmo(-),, úvula central, elevación palatina simétrica, lengua motilidad N, ECM M5 bilateral, trapecio izq M5 y der M3
-Motor: BC izq M5, ESD M0 (logra discreta extensión parcial de índice), EII M2, RCP extensor derecho y flexor izquierdo
-Sensitivo: conservado
-Cerebelo: conservado a izq, n/e a derecha por paresia
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO